รายงานการประชุม

คณะผู้วิจัยโครงการ TN-iLTC (Thailand Integrated Long-Term Care Framework)

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2569

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/บทบาทในโครงการ
1	ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	หัวหน้าโครงการ (ประธาน)
2	รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
3	ดร.รุ่งนภา คำผาง	คณะผู้วิจัย
4	พญ.ณัฐณิชา มานะบริบูรณ์	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP1)
5	นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP3) / ผู้จดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 ภาพรวมโครงการและโครงสร้าง Work Package

โครงการมีระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 8 เดือน แบ่งเป็น 3 Work Packages (WP) ซึ่งโดยภาพรวมแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 (WP1 และ WP2) การนำมาตรฐาน WHO Global Standards for Long-Term Care มาเทียบเคียงกับบริบทของประเทศไทย ต่อด้วยการจัดลำดับความสำคัญด้วยกระบวนการ Delphi โดย WP1 และ WP2 ดำเนินการต่อเนื่องกัน
- ส่วนที่ 2 (WP3) การพัฒนาเกณฑ์การเข้าถึงบริการตามความจำเป็น (need-based eligibility criteria) และจุดเปลี่ยนผ่านของการดูแล

จากการหารือครั้งก่อน WP1 และ WP3 สามารถดำเนินการคู่ขนานกันได้ โดยแยกผู้รับผิดชอบ แต่ต้องมีจุดรอผลร่วมกันในบางขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ร่างแผนการดำเนินงานและการแบ่งงานช่วง 2 เดือนแรก (8 สัปดาห์)

ร่างแผนการดำเนินงานเป็นร่างเบื้องต้นที่ต้องให้คณะผู้วิจัยร่วมพิจารณา โดยกำหนดให้ 2 เดือนแรก เป็นช่วงเตรียมข้อมูล และแบ่งผู้รับผิดชอบเป็น 3 คน ดังนี้

ช่วงเวลา	แพทย์ 1 - WP1	แพทย์ 2 - WP3	แพทย์ 3 - coordinate
สัปดาห์ที่ 1-2	- กำหนดคำถาม searching term - Database/แหล่งข้อมูลเทียบกับ 7 standards - Develop extraction form	- กำหนด questions - กำหนด assessment domains - Transition evidence	- ประเมิน template / question
สัปดาห์ที่ 3-4	- ค้นหา/คัดกรองเอกสาร - สกัดข้อมูล match 7 domains (based on รายงานเชิงนโยบาย)	- ค้นเกณฑ์ need-based / การ stratification population ทั้ง IMC -> LTC - มองหา non-cancer palliative triggers	- ช่วยค้นข้อมูล independently - นัดประชุม review gap
สัปดาห์ที่ 5-6	- ร่าง Thailand system Mapping - กำหนด gap matrix	- ร่าง assessment domain map - ร่าง candidate triggers - พัฒนา care pathway	- ตรวจสอบความเชื่อมโยง - ร่างประเด็นนโยบายและความเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 7-8	- สรุป WP1 evidence synthesis - ร่าง gap สำหรับการทำ Delphi	- ทำ WP3 evidence-to-design matrix prototype - Identified consensus point	- ตรวจสอบ evidence synthesis, design matrix

- **แพทย์คนที่ 1 (WP1):** ตามตารางข้างต้น โดยทั้งนี้ WP1 มีรายงานฉบับเดิมของหน่วย (รายงาน IMC/LTC เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน) เป็นฐาน แต่ต้องค้นเพิ่มว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- **แพทย์คนที่ 2 (WP3):** ดำเนินการเรื่อง need-based eligibility criteria ซึ่งแทบไม่มีข้อมูลเดิม ต้องสืบค้นใหม่ทั้งหมด ได้แก่ assessment domain ที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการคัดเลือกผู้รับ

บริการเข้าสู่ระบบ LTC และจุดเปลี่ยนผ่าน (transition point) ของการดูแล อาจจัดรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ในช่วงเดือนที่ 6 - 7

- **แพทย์คนที่ 3 (ผู้ประสานงาน):** ติดตามความก้าวหน้า ร่วมพิจารณาเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน
- **รอบการประชุม:** ผู้รับผิดชอบ 3 คนประชุมร่วมกันทุก 1 - 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค และประชุมทั้งทีม (รวม ดร.รุ่งนภา และ อ.วราลักษณ์) ทุก 2 - 4 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบประเด็นที่ยังขาดและแก้ไขได้ทันเวลา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานในหลักการ ให้แก้ไขคอลัมน์ "แพทย์ 2 – WP2" เป็น WP3 และปรับรายละเอียดตามมติในระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รูปแบบการศึกษาของ WP3

ที่ประชุมเห็นตรงว่า แผนโดยรวมเหมาะสม แต่ขอให้ผู้รับผิดชอบ WP3 สืบค้นก่อนว่าเคยมีผู้ทำ systematic review ในประเด็นเดียวกันหรือไม่ เนื่องจาก WP3 เป็นการหาเครื่องมือและเกณฑ์ ซึ่งเหมาะกับการทำ systematic review อย่างยิ่ง ข้อดีคือ

(1) ได้ผลงานวิชาการและตีพิมพ์ได้

(2) มีน้ำหนักในการนำเสนอผู้กำหนดนโยบายว่าควรดำเนินการแนวทางใด แล้วจึงปรับให้เหมาะกับบริบทไทย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ จึงอาจมี systematic review อยู่แล้ว

- หากยังไม่มี ควรออกแบบ WP3 เป็น systematic review ซึ่งต้องมีผู้ทบทวนอย่างน้อย 2 คน ไม่สามารถทำคนเดียวได้
- หากต้องการกำลังคนเพิ่ม สามารถหาผู้ช่วยสืบค้นหรือช่วยในกระบวนการ systematic review ได้
- WP1 สืบค้นอย่างเดียวได้ เพราะครอบคลุมเฉพาะประเทศไทย ส่วน WP3 น่าจะต้องทำเป็น systematic review
- ผู้รับผิดชอบ 2 คน เพียงพอสำหรับการทำ systematic review แต่ต้อง explore เรื่องคำศัพท์และคำค้นก่อน

มติที่ประชุม มอบหมายให้ หม่อน explore เรื่องการกำหนดคำถามวิจัยของ WP3 และสืบค้นว่ามี systematic review ในประเด็นเดียวกันอยู่แล้วหรือไม่ หากมีให้พิจารณานำมาใช้หรือสืบค้นเพิ่มเติม หากไม่มีให้ออกแบบเป็น systematic review และนำเสนอผลในการประชุมครั้งถัดไป

4.2 แนวทางการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลของ WP1

การกำหนดคำค้นและแหล่งข้อมูลล่วงหน้าช่วยให้การสืบค้นเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้ ผลของ WP1 จะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ Delphi ซึ่งจัด 2 รอบ นอกจากนี้ หลังได้ผลการทบทวนวรรณกรรมควรมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (มีงบประมาณแล้ว) เพื่อพิจารณาว่าเกณฑ์ที่ทบทวนได้ควรนำสิ่งใดมาใช้ในประเทศไทย แล้วจึง verify ในการประชุมที่ใหญ่ขึ้น

โดยมี plan ทำตามตัวชี้วัด (indicator) ดังนี้

- กางตัวชี้วัดของ WHO และระบุว่าแต่ละตัวชี้วัดต้องการข้อมูลอะไร
- ตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่
- เทียบกับรายงาน UHC ฉบับเดิม ว่าตอบได้ครบหรือไม่ ส่วนที่ขาดจึงสืบค้นเพิ่ม
- ประเมินปริมาณงานที่เหลือ

ทั้งนี้ ข้อจำกัดของประเทศไทยคือเอกสารบางส่วนไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ต้องขอจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

มติที่ประชุม WP1 ใช้การสืบค้นอย่างเป็นระบบ (ไม่ต้องทำ systematic review) โดยเริ่มจากตัวชี้วัดของ WHO แล้วเทียบกับรายงานฉบับเดิม ของ UHC Day โดยมอบหมายให้ พี่เมจิ เป็นผู้ explore และนำเสนอผลในการประชุมครั้งถัดไป

4.3 คำศัพท์ในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลต่างประเทศ

คำศัพท์ในบริบท long-term care แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเส้นแบ่งระหว่าง intermediate care กับ long-term care ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เช่น ออสเตรเลียใช้คำว่า subacute care สำหรับ intermediate care และใช้ care package สำหรับการเข้าสู่ LTC หากสืบค้นด้วยคำว่า long-term care เพียงคำเดียวจะตกหล่นข้อมูล โดยเฉพาะในประเทศรายได้สูง นอกจากนี้ ข้อมูลเกณฑ์จำนวนมากอยู่ในรูป white paper หรือเอกสารของภาครัฐมากกว่าบทความวิชาการ

มติที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบ explore ข้อมูลก่อน แล้วนัดหารือเรื่องคำศัพท์และคำค้นอีกครั้ง เพื่อให้การสืบค้นตรงประเด็นและไม่กว้างเกินไป

4.4 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ สวรส. และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (IRB)

- ให้สอบถามผู้ประสานงานของ สวรส. ให้ชัดเจนถึงกระบวนการทำงานของ reviewer ว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่
- นอกจากนี้ โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษ และที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำใน workshop (อ.สุวิทย์? และ อ.วิโรจน์?) อาจถือว่าเป็นการ review โครงการไปในตัวแล้ว จึงจำเป็นต้อง explore เรื่อง COI เพิ่ม

- เรื่อง IRB สามารถยื่นฉบับเดียวได้ โดยระบุว่าโครงการประกอบด้วยงานกี่ส่วน ส่วนงานทบทวนเอกสารสามารถเริ่มได้โดยไม่ต้องรอ IRB อนุมัติ และดำเนินการคู่ขนานไปได้ ส่วนการจัดประชุมให้ดำเนินการหลังได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุม (1) ประธานติดตามคำตอบจากผู้ประสานงาน สวรส. เรื่องกระบวนการ review (2) สอบถามประเด็น COI (3) ยื่น IRB ฉบับเดียวครอบคลุม WP1 - 3 และเริ่มงานทบทวนเอกสารได้ทันที

4.5 การแบ่งผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา

ที่ประชุมเห็นตรงว่า หากไม่แบ่งงานชัดเจนจะเกิดช่องว่างที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบเขียน job description ของตนให้ชัดเจน

มติที่ประชุม หม่อน รับผิดชอบ WP3 และ พี่เมจิ รับผิดชอบ WP1 ในช่วง explore ให้ทั้งสองคนเขียน job description และนำเสนอผลการ explore ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมกำหนดนัดภายใน 2 สัปดาห์ (ช่วงวันที่ 5–9 ตุลาคม 2569)

มติที่ประชุม กำหนดประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น.

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย

ที่	ผู้รับผิดชอบ	งาน	กำหนดส่ง
1	อ.หฤษฎ์	ติดตามคำตอบจากผู้ประสานงาน สวรส. เรื่องกระบวนการ review ข้อเสนอโครงการ	ก่อน 8 ต.ค. 2569 → มีค่ะคุณหมอ ขณะนี้ proposal อยู่ในระหว่างผู้ทรง review อยู่ค่ะ แจ้งกระบวนการคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ Review ---> ปรับข้อเสนอตาม comments ผู้ทรง ---> ปรับรายละเอียดงบประมาณและกิจกรรม เมื่อ proposal ปรับครบแล้ว จะเริ่มกระบวนการ ทำข้อตกลงโครงการวิจัยค่ะ
2	อ.หฤษฎ์	สอบถาม สวรส. เรื่อง COI ของที่ปรึกษาที่มีชื่อในทีม	ก่อน 8 ต.ค. 2569
3	อ.หฤษฎ์	จัดเตรียม IRB เพื่อครอบคลุม WP1 - 3	ดำเนินการต่อเนื่อง
4	พี่เมจิ	Explore WP1	8 ต.ค. 2569
5	หม่อน	Explore WP3	8 ต.ค. 2569
6	พี่เมจิ, หม่อน	เขียน job description ของแต่ละคน	8 ต.ค. 2569
7	คณะผู้วิจัย	หารือและตกลงคำศัพท์/คำค้นร่วมกัน	ประชุม 8 ต.ค. 2569